

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

MIGRÉTIL

Traitement des crises de migraine

1. Dénomination du médicament

MIGRÉTIL, comprimés

2. Composition qualitative et quantitative

Paracétamol 400 mg; caféine 100 mg; tartrate d'ergotamine 1 mg; alcaloïdes de la belladone 0,1 mg; par comprimé.

3. Forme pharmaceutique

Comprimés non enrobés.

4. Données cliniques**4.1. Indications thérapeutiques**

Traitement des crises de migraine. Il ne prévient pas l'apparition des crises.

4.2. Posologie et mode d'administration

Sauf indication médicale en contraire la posologie recommandée est la suivante:

Adultes: Deux comprimés à la fois, pendant l'aura ou au commencement de la céphalée. Si nécessaire, administrer un autre comprimé après une demi-heure, cette dose pouvant être répétée après une autre demi-heure.

Adolescents: Un comprimé pendant l'aura ou le commencement de la céphalée. Si nécessaire, administrer un autre comprimé après une demi-heure.

Il n'est pas indiqué chez l'enfant âgé moins de 12 ans.

Les comprimés sont à avaler le plus tôt possible, dès les premiers symptômes de la crise de migraine.

Ne pas avaler plus de 6 comprimés par jour ou plus de 10-12 comprimés par semaine.

Les comprimés sont à avaler entiers avec de l'eau.

4.3. Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants. Grossesse et allaitement, alcoolisme actif, insuffisance hépatique significative. Angioplastie ou chirurgie vasculaire récentes ou prévues, maladie vasculaire périphérique occlusive, hypertension non contrôlée, maladie coronarienne.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Le risque de complications est augmenté en cas d'infections graves ou d'insuffisance rénale significative, et aussi chez les sujets âgés.

Chez les malades ayant des troubles de l'anxiété, la caféine peut exacerber les symptômes. Il faut éviter l'administration simultanée de boissons contenant de la caféine.

Les patients avec une hypertrophie prostatique, une rétention urinaire, une maladie gastro-intestinale occlusive ou un glaucome peuvent souffrir de l'action toxique due aux résultantes des alcaloïdes de la belladone, bien que les doses utilisées dans le MIGRÉTIL soient très basses.

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Les xanthines peuvent augmenter les effets des stimulants bêta-adrénergiques. L'utilisation concomitante de stimulants du système nerveux central peut provoquer des effets additifs et indésirables, tels que nervosité, irritabilité, insomnie, convulsions et arythmies. L'utilisation concomitante d'inhibiteurs de la monoamine-oxydase peut entraîner une tachycardie, des arythmies ou une hypertension. La caféine antagonise les effets de l'adénosine et des bêtabloquants.

L'administration concomitante de vasoconstricteurs systémiques (cocaïne, épinéphrine, métaraminol, méthoxamine, norépinephrine, phényléphrine, solutions anesthésiques locales avec des vasoconstricteurs, amines sympathicomimétiques) et également le tabagisme potentialisent les effets vasopresseurs des alcaloïdes de l'ergot de seigle. Cette classe de médicaments antagonise les effets vasodilatateurs de la nitroglycérine. Il faut prendre des mesures spéciales lors de l'administration simultanée de propranolol et de doses élevées d'alcaloïdes de l'ergot de seigle du fait du risque de vasoconstriction périphérique grave.

L'ingestion excessive d'alcool peut augmenter le risque d'hépatotoxicité induite par le paracétamol.

La caféine potentialise les effets des autres xanthines, pouvant diminuer son élimination. L'érythromycine et la troléandomycine diminuent le métabolisme des alcaloïdes de l'ergot du seigle, augmentant le risque de vasospasme.

4.6. Grossesse et allaitement

Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aux doses thérapeutiques recommandées, il n'existe aucune interférence.

4.8. Effets indésirables

Aux doses recommandées MIGRÉTIL est habituellement bien toléré. Il peut survenir des réactions d'hypersensibilité cutanée, des signes d'irritation gastrique, diarrhée, insomnie, nervosité, myalgies, paresthésies et diminution de la force des membres inférieurs. Les effets vasoconstricteurs peuvent se faire sentir dans certains vaisseaux, bien qu'il existe de grandes variabilités interindividuelles. Ces effets se traduisent par extrémités froides, engourdis et douloureux, avec ou sans paresthésies.

4.9. Surdosage

Des cas de dose excessive ou d'intoxication aiguë, peuvent, occasionnellement, survenir chez les patients prenant des doses beaucoup plus élevées que celles recommandées ou par des sujets avec des tendances suicidaires. Les symptômes de surdosage peuvent comprendre nausées, vomissements, douleur abdominale, céphalées, excitabilité, agitation, scotomes, tinnitus, tremblements, tachycardie, arythmies, augmentation de la diurèse, myalgies, paresthésies, faiblesse des membres inférieure et extrémités froides, engourdis ou douloureux. Dans les cas plus graves, on peut observer angor, cécité monoculaire transitoire, papillite bilatérale, colite ischémique, vasoconstriction de l'artère rénale, gangrène des extrémités, nécrose hépatique, altération de la fonction mentale, dyspnée, hypo ou hypertension, pouls faible, spasmes musculaires, convulsions, choc et mort.

Le traitement des situations de surdosage aigu consiste en des mesures générales de soins et un traitement symptomatique. L'induction de vomissement et le lavage gastrique sont importants si l'ingestion du médicament a eu lieu moins de 4 heures auparavant, avec administration de charbon activé. L'utilisation de émulsifs peut réduire l'irritation gastrique. On doit pourvoir l'échauffement des extrémités, et, éventuellement, administrer des vasodilatateurs et de l'héparine. En cas de nécrose hépatique secondaire au paracétamol, il faut administrer de l'acétylcystéine dans les premières 24 à 36 heures, étant plus grande l'efficacité en fonction de la précocité.

5. Propriétés pharmacologiques

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Classification ATC: N02CA - Préparations antimigraineuses, alcaloïdes ergotaminiques

Paracétamol: Il a des effets analgésiques et antipyrétiques dus à un mécanisme pas complètement éclairé, mais qui peut être semblable à celui des salicylés. En termes d'analgésie, le paracétamol pourrait agir en inhibant la synthèse des prostaglandines au niveau du système nerveux central et de façon moins importante, et de façon moins importante, l'apparition du signal de la douleur, en périphérie. L'action périphérique pourra aussi être attribuable à l'inhibition de la synthèse des prostaglandines ou à l'inhibition de la synthèse et/ou de l'action d'autres substances qui sensibilisent les récepteurs de la douleur à la stimulation mécanique ou chimique.

Caféine: C'est une méthylxanthine qui existe naturellement dans le thé et dans le café, mais qui est préparée synthétiquement pour une utilisation commerciale. Elle potentialise l'action des alcaloïdes de l'ergot de seigle dans le traitement de la migraine, augmentant l'absorption gastro-intestinale de l'ergotamine.

La caféine peut aussi contribuer à la vasoconstriction cérébrale et par conséquent à la réduction du flux sanguin et de l'apport d'oxygène. Elle est associée à des analgésiques, tels que le paracétamol dans le traitement de la céphalée. La caféine n'exerce aucun effet analgésique intrinsèque, toutefois les associations contenant de la caféine ont été décrites comme entraînant un effet analgésique plus rapide et plus puissant, permettant de réduire les

doses de la substance analgésique.

Tartrate d'ergotamine: C'est un alcaloïde de l'ergot de seigle, qui est un agent important pour le soulagement symptomatique de la céphalalgie de la migraine, particulièrement chez les malades où les médicaments comme l'aspirine seul donnent un soulagement incomplet. Il a des effets pharmacologiques complexes. Aux doses thérapeutiques, il provoque une vasoconstriction périphérique stimulant les récepteurs alpha-adrénergiques et provoquant une dépression des centres vasomoteurs centraux.

Le mécanisme par lequel l'ergotamine agit sur les céphalées d'étiologie vasculaire semble être dû aux effets directs de la vasoconstriction sur les artères carotides externes, provoquant la réduction de l'amplitude du pouls. L'effet de l'ergotamine sur les catécholamines et sur la sérotonine peut contribuer à l'efficacité thérapeutique.

Alcaloïdes de la belladone: Sont des médicaments anticholinergiques. Toutefois, les doses utilisées dans le MIGRÉTIL ne sont pas suffisantes pour que se produise cet effet.

La stase gastrique, les nausées et vomissements, sont des symptômes et des signes présents dans la plupart des cas de migraine. Les alcaloïdes de la belladone exercent un effet antiémétique bénéfique, contribuant au soulagement symptomatique de la crise.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Paracétamol: Est rapide et presque totalement absorbé par le tractus gastro-intestinal. La concentration maximale s'obtient dans 10 à 60 minutes. Après une dose de 500 mg, la concentration maximale est de 2,1mcg/mL. La distribution du paracétamol est rapide et uniforme dans la plupart des tissus, y compris le lait maternel. Il traverse le placenta. Environ 25% de la concentration plasmatique du paracétamol se lie aux protéines plasmatiques. La demi-vie d'élimination plasmatique est de 1,25 à 3 heures. Il est métabolisé par les enzymes microsomales hépatiques. Environ 80-85% de la dose administrée est conjuguée avec l'acide glucuronique et d'une façon moins importante avec l'acide sulfurique. Une quantité réduite de paracétamol est encore conjuguée avec la cystéine. Le paracétamol est excrété par voie urinaire, sous forme conjuguée ou libre. Après une prise unique de paracétamol, environ 85% est excrété par cette voie dans les premières 24 heures.

Caféine: Est facilement absorbée à partir du tractus gastro-intestinal, étant l'absorption orale supérieure à l'absorption par voie intramusculaire. Après une dose orale de 100 mg, la concentration maximale est de 1,5-1,8 mcg/mL, 50-75 minutes après administration. La distribution est large et rapide, traversant la barrière hémato-encéphalique et le placenta et passant au lait maternel. Environ 17% de la caféine se lie aux protéines plasmatiques. Elle est partiellement déméthylée, oxydée et acétylée dans le foie, et ses métabolites sont excrétés dans l'urine. Seul 1% est excrété sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination plasmatique est de 3 à 4 heures chez l'adulte, pouvant être supérieure à 100 heures chez les nouveau-nés.

Tartrate d'ergotamine: Après administration orale, l'absorption de l'ergotamine est variable, et est diminuée par la stase gastrique qui accompagne habituellement la migraine. L'absorption est plus importante au cours de la première heure après l'administration, surtout si on l'administre la caféine en même temps. L'effet de premier passage hépatique entraîne une réduction de la biodisponibilité. Il traverse la barrière hémato-encéphalique et est détecté dans le lait maternel. Environ 95% circule lié aux protéines plasmatiques. Le temps pour atteindre la concentration maximale est de 2 heures, se réduisant de moitié si on administre concomitamment de la caféine. L'action dépend de la précocité de l'ingestion de l'ergotamine par rapport avec le début de la céphalée. Après administration de l'ergotamine chez les sujets ayant une fonction rénale et hépatique normale, les concentrations plasmatiques baissent de façon diphasique, avec une demi-vie moyenne initiale de 2,7 heures et finale de 21 heures. L'ergotamine, et spécialement le composant peptidique de la molécule, est métabolisée presque totalement, probablement au niveau hépatique. Quelques métabolites pourront être pharmacologiquement actifs. La principale voie d'excrétion est fécale (biliaire), la voie urinaire n'excrétant seulement que 4%.

Alcaloïdes de la belladone: Les alcaloïdes de la belladone sont bien absorbés par le tractus gastro-intestinal. On sait peu de chose concernant la distribution, le métabolisme et l'excrétion. Ils sont probablement hydrolysés en tropine et en acide tropique, qui sont les dérivés excrétés dans l'urine et, de façon moins importante, dans les fèces.

6. Données pharmaceutiques**6.1. Liste des excipients**

Polivydone K30, acide tartrique, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, Eudragit E, méthylhydroxypropylcellulose, diéthylphthalate et Opaspray K-1-7000.

6.2. Incompatibilités

Le sulfate d'atropine est incompatible avec les bases, l'acide tannique et les sels de mercure.

Le bromhydrate de scopolamine est incompatible avec les bases, les sels d'argent et l'acide tannique.

6.3. Durée de conservation

Deux ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Conserver le produit à l'abri de la lumière et humidité, à température contrôlée (15-30°C).

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Étui de carton avec 20 comprimés en plaquette Alu/Alu ou film thermosoudé Alu/PE et une notice.

6.6. Précautions particulières d'élimination

Pas d'exigences particulières.

7. Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

BIAL-Portela & C^a, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

8. Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché

11340

9. Date de Première Autorisation/de Renouvellement de l'Autorisation

1999.05.11 / 2004.01.05 / 2008.09.25

10. Date de Mise à Jour du texte